



Universidad Latinoamericana
de Comercio Exterior

Trastorno Esquizotípico de la Personalidad

Coparropa, Miguel 6-707-1896
Harris, Kitzi 6-717-1006
Ortega, Patricia 4-763-1154
Palma, Luz 6-704-1871

Profa. Aelen López





“No todas las personas experimentan la realidad de la misma forma; algunas viven constantemente entre el deseo de pertenecer y la sensación de sentirse diferentes.”

Causas

El trastorno esquizotípico de la personalidad puede desarrollarse por la combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. Existe mayor riesgo en personas con antecedentes familiares de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. También pueden influir experiencias traumáticas, dificultades sociales y alteraciones en el funcionamiento cerebral.



Criterios

- Ideas de referencia.
- Creencias extrañas o pensamiento mágico.
- Experiencias perceptivas inusuales.
- Forma de hablar vaga, extraña o muy peculiar.
- Suspicasia o pensamientos paranoides.
- Expresión emocional limitada o inapropiada.
- Conducta o apariencia excéntrica.
- Pocas relaciones cercanas fuera de familiares.
- Ansiedad social intensa que no disminuye con la confianza y suele relacionarse con paranoia más que con timidez.



DSM 5 TR - CIE 11

Eje de Comparación	DSM-5 TR (Sección de Trastornos de Personalidad)	CIE-11 (Sección de Espectro de la Esquizofrenia)
Clasificación	Lo considera estrictamente un Trastorno de la Personalidad (Grupo A).	Lo clasifica dentro de los Trastornos Psicóticos, reconociendo el vínculo biológico con la esquizofrenia.
Criterios	Rígido: Requiere cumplir al menos 5 de los 9 criterios enlistados.	Descriptivo: No exige un número exacto, sino un patrón de funcionamiento persistente.
Psicopatología (Pensamiento)	Énfasis en ideas de referencia y pensamiento mágico (supersticiones, telepatía).	Énfasis en creencias inusuales y distorsiones cognitivas generales.

DSM 5 TR - CIE 11

Eje de Comparación	DSM-5 TR (Sección de Trastornos de Personalidad)	CIE-11 (Sección de Espectro de la Esquizofrenia)
Percepción	Habla principalmente de ilusiones corporales (sentir una presencia o deformar lo real).	Admite la presencia de alucinaciones reales (auditivas, visuales, etc.) si son breves o de baja intensidad.
Sintomatología Negativa	Describe un afecto restringido o inapropiado.	Introduce formalmente la Anhedonia (incapacidad de sentir placer) como rasgo clave.
Ansiedad Social	Especifica que es una ansiedad que no disminuye con la familiaridad y tiene tintes paranoides.	Se enfoca en la capacidad reducida para las relaciones y la incomodidad interpersonal general.

DSM 5 TR - CIE 11

Eje de Comparación	DSM-5 TR (Sección de Trastornos de Personalidad)	CIE-11 (Sección de Espectro de la Esquizofrenia)
Lenguaje y Habla	Detalla formas específicas: habla vaga, metafórica o sobreelaborada.	Lo define de forma global como excentricidades en el discurso.
Duración y Evolución	Indica que los rasgos deben ser visibles desde la edad adulta temprana.	Especifica que el patrón debe mantenerse por varios años para ser considerado diagnóstico.
Especificadores	Permite agregar el término "Premórbido" si el trastorno aparece antes de una esquizofrenia.	No usa el término premórbido; se enfoca en el deterioro funcional actual (social, laboral, educativo).

TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA PERSONALIDAD (TEP)

0.6%–3.9%

Rango de prevalencia estimado
en la población general.

**1 de cada
300 personas**

Frecuencia aproximada de afectación.
Inoración.

- * El TEP pertenece al espectro esquizofrénico según la OMS.
- * Su prevalencia global se estima entre 0.6% y 3.9%.
- * En Panamá no existen estadísticas nacionales específicas.
- * Muchos casos permanecen subdiagnosticados o confundidos con otros trastornos.

Síntomas y Diagnóstico Temprano

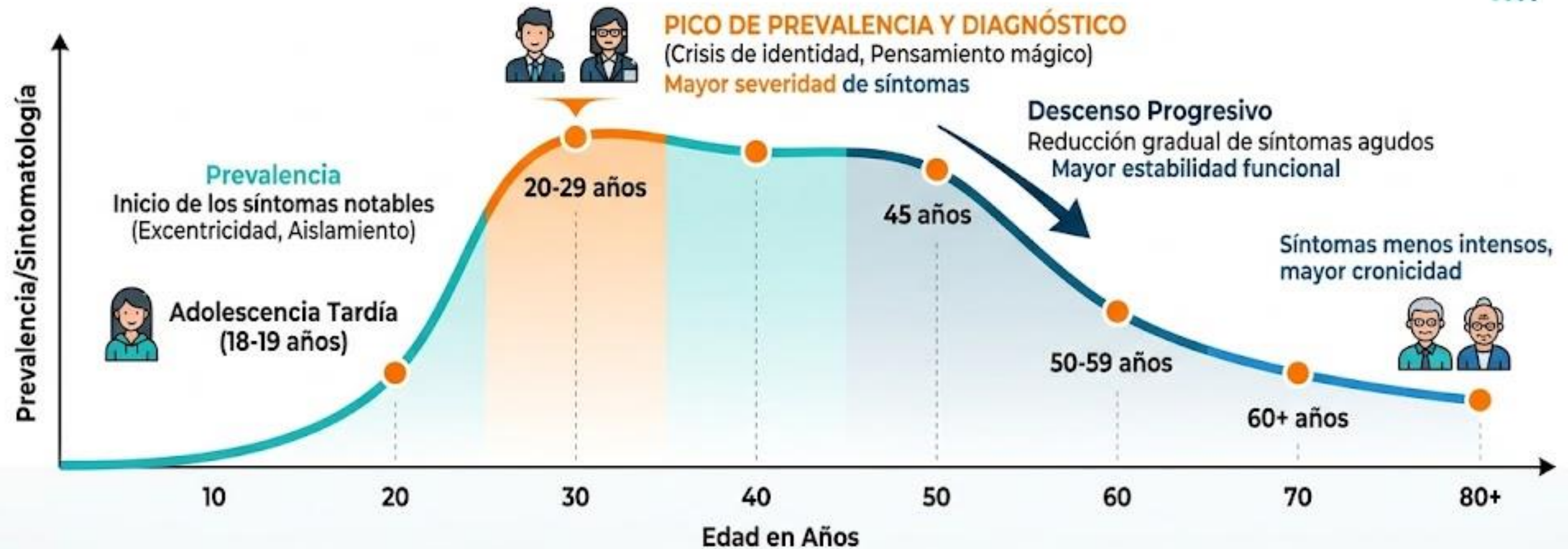
SÍNTOMAS DEL TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA PERSONALIDAD

GUÍA CLÍNICA PROFESIONAL



La Juventud: Etapa Crítica del TEP

CRONOLOGÍA DEL TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA PERSONALIDAD POR EDADES



ADOLESCENCIA TARDÍA

Inicio de rasgos disfuncionales

- Ideas de referencia
- Ansiedad social
- Comportamiento excéntrico



ADULTOS JÓVENES 20-29

Pico de síntomas y diagnóstico

- Ideas de referencia
- Ansiedad social
- Comportamiento excéntrico



MADUREZ Y ENVEJECIMIENTO (>45 años)

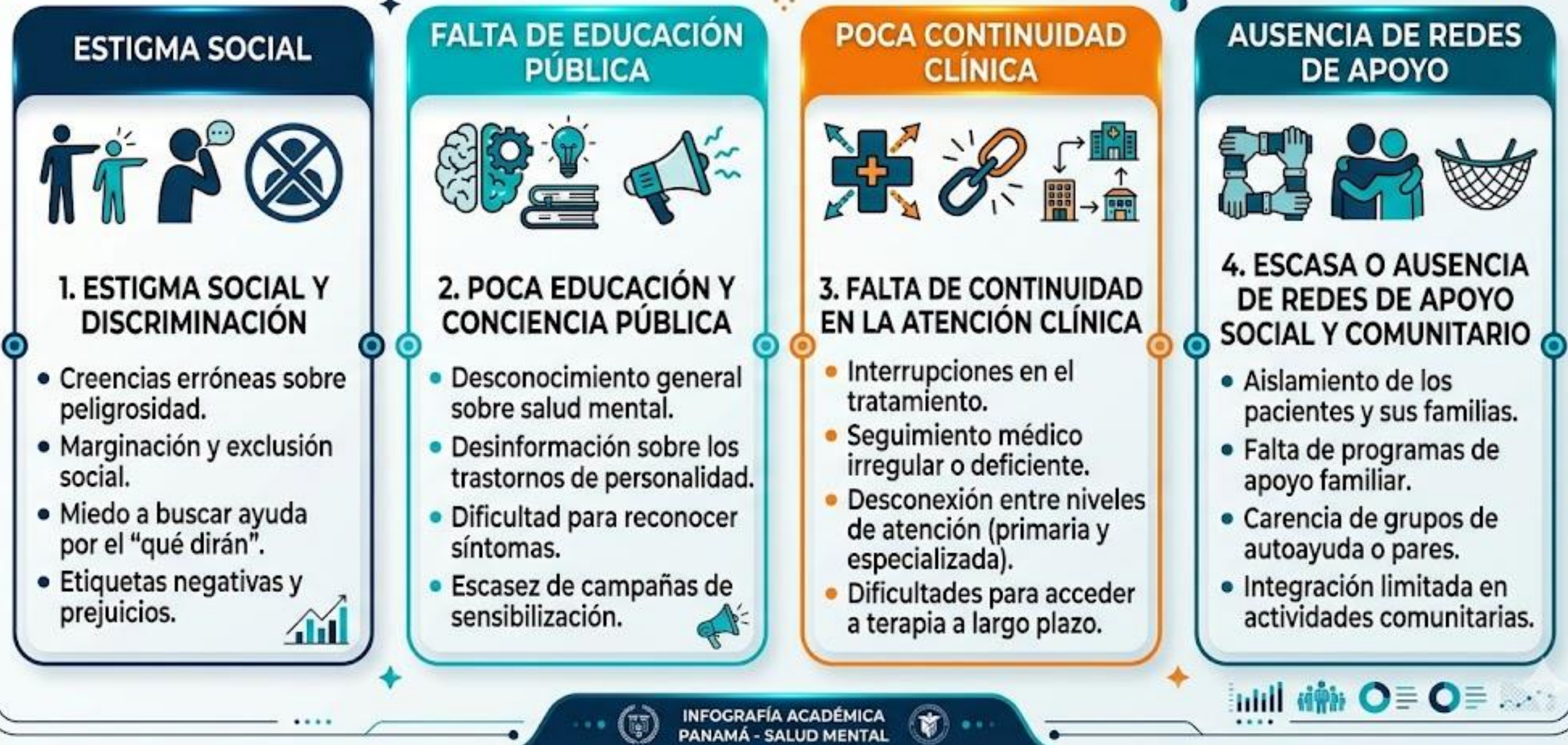
Disminución de intensidad sintomática

- Estabilidad internlevocultos
- Estabilidad laboral/social

El Vacío en Panamá y las Barreras del Sistema

Conclusión

BARRERAS DEL SISTEMA DE SALUD MENTAL EN PANAMÁ RELACIONADAS CON EL TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA PERSONALIDAD (TEP)



El TEP necesita mayor visibilidad, estadísticas específicas y programas de detección temprana en Panamá.

Investigación Científica del Trastorno Esquizotípico de la Personalidad

Estudio 1: Revisión Sistemática sobre Esquizotipia

Objetivo del estudio

- Comprender cómo se evalúan los rasgos esquizotípicos y su relación con el espectro de la esquizofrenia.

Hallazgos principales

- * Alteraciones en el pensamiento.
- * Dificultades sociales importantes.
- * Conductas excéntricas.
- * Experiencias perceptivas inusuales.

Conclusión:

El Trastorno de la Personalidad Esquizotípico comparte características con la esquizofrenia, aunque presenta menor gravedad y mayor conservación del contacto con la realidad.

Referencia bibliográfica

Rivera Tapia, C. J. (2022). Assessment in Schizotypy: A Systematic Review Towards Clinical and Personality Models. International Journal of Psychological Research. Recuperado de Redalyc.



Investigación Científica del Trastorno Esquizotípico de la Personalidad

Estudio 2: Bases Biológicas y Neurológicas del TPE

Objetivo del estudio

- Investigar las bases biológicas y neurológicas relacionadas con el trastorno esquizotípico.

Hallazgos principales

- * Alteraciones cognitivas.
- * Anomalías cerebrales similares a la esquizofrenia.
- * Cambios en áreas relacionadas con la dopamina y la corteza temporal.

Conclusión:

Las personas con trastorno esquizotípico presentan mecanismos de protección neurológica que disminuyen la probabilidad de desarrollar una psicosis completa.

Referencia bibliográfica

Marín, J. L. (2007). Tratamiento farmacológico de los trastornos de personalidad. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Recuperado de SciELO España.



Investigación Científica del Trastorno Esquizotípico de la Personalidad

Estudio 3: Experiencias Esquizotípicas en Adolescentes

Objetivo del estudio

- Analizar la presencia de síntomas relacionados con el espectro psicótico en adolescentes.

Hallazgos principales

- * Experiencias perceptivas extrañas.
- * Ideas inusuales.
- * Aislamiento social.
- * Mayor riesgo cuando los síntomas persisten.

Conclusión:

La combinación de factores genéticos y ambientales puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos graves del espectro esquizofrénico, incluyendo el Trastorno de la Personalidad Esquizotípico.

Referencia bibliográfica

Fonseca-Pedrero, E. (2015). Experiencias esquizotípicas en la adolescencia. Acción Psicológica. Recuperado de SciELO España.



Famosos Relacionados con Rasgos Esquizotípicos



Nikola Tesla

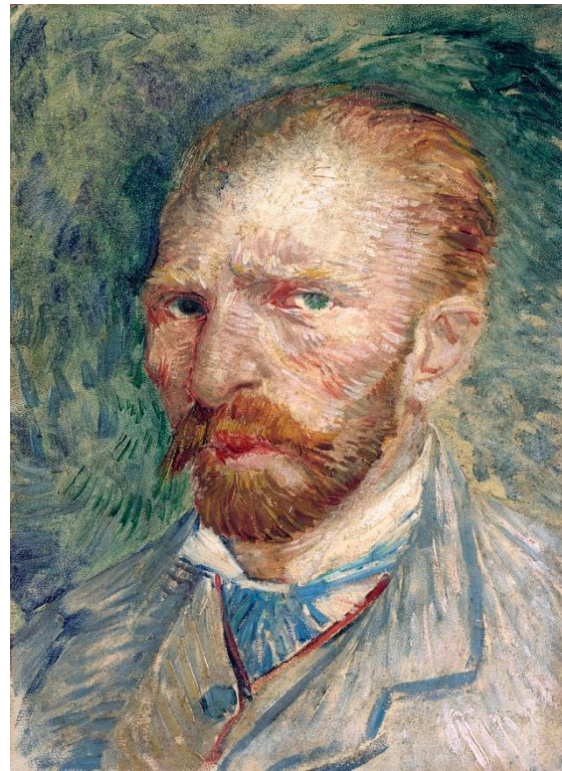
- Tesla mostraba conductas peculiares, rituales obsesivos y una forma de pensamiento extremadamente abstracta. Diversos biógrafos han señalado la presencia de rasgos compatibles con el espectro esquizotípico, aunque nunca fue diagnosticado formalmente.



Syd Barrett

El fundador de Pink Floyd presentó conductas excéntricas, retraimiento social y alteraciones cognitivas progresivas. Algunos especialistas han planteado que pudo haber presentado un trastorno dentro del espectro esquizotípico o psicótico.

Famosos Relacionados con Rasgos Esquizotípicos



Vincent van Gogh

- El reconocido pintor neerlandés ha sido objeto de múltiples hipótesis psiquiátricas. Algunos autores consideran que presentaba rasgos esquizotípicos debido a su pensamiento excéntrico, aislamiento social y experiencias perceptivas inusuales reflejadas en su arte.



Emily Dickinson

La poeta estadounidense vivió gran parte de su vida en aislamiento. Sus escritos reflejan un mundo interno intenso y profundamente simbólico, lo que ha llevado a algunos investigadores a asociarla con rasgos esquizotípicos.

Conclusiones finales

Las investigaciones científicas actuales coinciden en que el Trastorno de la Personalidad Esquizotípico es una condición compleja en la cual existe influencia genética y ambiental en su desarrollo. La intervención psicológica temprana puede ayudar a mejorar las habilidades sociales, la regulación emocional y la calidad de vida de los pacientes.





Universidad Latinoamericana
de Comercio Exterior

Trastorno Esquizotípico de la Personalidad

¡MUCHAS GRACIAS!

